

Anamnèse pédiatrique générale

1. Caractériser la plainte
2. État général
 - a. Tonus
 - b. Éveil
 - c. Nuits
3. Pleurs
 - a. Continus
 - b. Habituels
4. Repas
 - a. Nombre
 - b. Quantité
 - c. Qualité
5. Croissance
 - a. Courbes PC
 - b. Taille
 - c. Poids
6. Selles, urines, vomissement
 - a. Quantité
 - b. Qualité
7. Symptômes associés
 - a. EF**
 - b. Toux**
 - c. Rhinorrhée**
 - d. Rash**
8. Vaccination
9. Déroulement de la grossesse et de grossesses antérieures
10. Naissance
 - a. Voie basse
 - b. Césarienne
 - c. Complication ?
11. Adaptation néonatale
 - a. 1^{ère} minute de vie
 - b. 1^{ère} semaine
12. Anamnèse actuelle de la mère
 - a. + tabac, alcool, médicaments
13. Anamnèse psychosociale
 - a. Conjoint
 - b. Foyer
 - c. Travail
 - d. Stress, surmenage
14. Anamnèse familiale
 - a. Développement
 - b. Maladies

Évaluation urgence pédiatrique

1. Apparence

- a. État de conscience
- b. Tonus musculaire
- c. Contact

2. Respiration

- a. Position
- b. Travail respiratoire
 - i. FR
 - ii. Signes de lutte
 - 1. Tirage
 - 2. Battement des ailes du nez
 - 3. Balancement thoraco abdominal
- c. Bruits respiratoires
 - i. Stridor
 - ii. Grunting
 - iii. Sibilance

3. Hémodynamique

- a. Couleur des téguments (pâles, cyanoses)
- b. Chaleur (chaud, froid)

Urgence :

FR > 70
Respiration irrégulière avec pause
Cyanose
Grunting
Enfant ne boit plus, ne parle plus
État d'éveil altéré ou agité
Mauvaise perfusion périphérique
ou tachycardie importante

Triangle permet de distinguer
une pathologie banale ou
grave chez un enfant qui a de
la fièvre, qui pleure ou autre

Ensuite ABCDE

- Airway
- Breathing
 - o Signes de détresses respiratoires
- Circulation
 - o FC
 - o TA
 - o Évaluation de la perfusion
- Disability (état neurologique)
 - o État de conscience
 - Alert
 - Réponse à la voix
 - Réponse à la douleur
 - Absence de réponse
 - o Tonus
 - o Convulsions
 - o Irritabilité
 - o Léthargie
 - o État des pupilles
- Événements
 - o Évidence de trauma
 - o Brûlures
 - o Hémorragie
 - o Atteinte cutanée
 - o Mesurer la température

Pneumo pédiatrie

- Pathologie obstructive haute
 - Faux croup (*parainfluenza*): ttt symptomatique □ GCS + adrénaline à inspirer
 - **Brutal, IVRS dernièrement**
 - **Toux aboyante**
 - **Voix rauque**
 - Stridor
 - Peu de fièvre
 - Tachypnée
 - Tirage
 - Désaturation
 - Épiglottite (*haemophilus influenza*) □ ttt : ttt ATB
 - Aspect toxique – se penche en avant – **position de tripode**
 - **Fièvre élevée**
 - Voix patate chaude
 - **Pas de toux**
 - **Déglutition difficile**
 - **Salivation ++**
 - Obstruction sévère
 - Répond mal au ttt habituel
 - Stridor inspiratoire
 - Tirage
 - Cyanose
 - Corps étranger
 - Anamnèse de syndrome de pénétration
 - Âge
- Pathologie obstructive basse
 - Bronchiolite
 - < 2 ans
 - Rhinite
 - EF
 - Sibilances et râles crépitants
 - Effort respiratoire augmenté (muscles abdominaux, scalène)
 - Asthme/bronchite spastique
 - > 2 ans
 - Déclenché par IVRS
 - Sibilance
 - Réponse au beta2 agoniste
- Pathologie restrictive basse
 - Pneumonie
 - EF
 - Toux
 - Tachypnée
 - Tirage
 - Grunting si sévère
 - Râles

Diphthérie : apparition plus progressive, BEG, dysphagie

Cardio pédiatrique

- Insuffisance cardiaque
 - **Difficulté d'alimentation**
 - Tétée
 - Vomissement
 - Douleur abdominale
 - Troubles du transit
 - **Croissance staturo-pondérale**
 - **Sudations, malaises**
 - Dyspnée
 - Signes de détresse respiratoire
 - Toux
 - Wheezing
 - Râles
 - Stridor
 - Cyanose
 - Extrémité
 - Muqueuses (lèvre, intérieur de la bouche)
 - Hippocratisme digital
 - Oedèmes
 - Godet
 - Signe d'ascite
 - Distension jugulaire (reflux hépatojugulaire)
 - Douleurs thoraciques
 - Augmentent à l'effort □ à la tétée, nourrisson pleurt
 - Palpitation

Neuro pédiatrie

- Hypotonie
 - Périphérique
 - Aréflexie
 - Faiblesse et fatigabilité musculaire
 - Centrale
 - Hypotonie axiale
 - Léthargie
 - Éveil altéré
 - Hyperréflexie
 - Clonus
 - Persistance des mouvements archaïques
- Syndrome pyramidal
 - Parésie
 - Spasticité
 - Hyperréflexie
 - Signe de Babinski

Périmètre crânien :

- Macrocéphalie
 - Constitutionnel
 - Progressif
 - Hydrocéphalie
 - HT intracrânienne : fontanelle bombée, regard en soleil couchant, léthargie, irritabilité
 - Processus expansif
- Microcéphalie
 - Harmonieuse : congénitale
 - Malformation
 - Infection
 - Cause génétique
 - Cause métabolique
 - Progressive
 - Encéphalopathie anoxique
 - Lissencéphalie
 - Dégénérative

Pleurs

Anamnèse

1. Caractériser les pleurs
 - a. Habituels ou non
 - b. Qualité
 - c. Intensité
 - d. Durée
 - e. Fréquence
 - f. Évolution
 - g. Condition de survenue
 - h. Facteurs déclenchants
 - i. Voyages
 - ii. Alimentation
 - iii. Changement de rythme
 - i. Facteurs apaisant
 - i. Calmé quand dans les bras ?
2. Manifestation associée
 - a. Rash
 - b. EF
3. Retentissement
 - a. Sommeil
 - b. Alimentation
 - c. Jeu
4. Toujours penser à la maman, un épuisement peut avoir une répercussion sur l'enfant
 - a. !!! shaken baby syndrome
5. Notion de traumatisme ?
6. Croissance
 - a. Courbes PC
 - b. Taille
 - c. Poids
7. Suivi médical
 - a. Vaccination
8. Anamnèse psychosociale
 - a. Conjoint
 - b. Foyer
 - c. Travail
 - d. Stress
 - e. Surmenage
 - f. !!! Histoire de grossesse compliquée, accouchement traumatique !!!



Examen clinique

☑ complet et minutieux (conscience, respiratoire, cardiaque/circulatoire, abdomen, urogénital, ORL, peau, oculaire, ostéoarticulaire)

Fièvre du bébé

Anamnèse

1. TEP
 - a. Apparence
 - i. Conscient ?
 - ii. Contact ?
 - iii. Joue ?
 - iv. Irritable ?
 - b. Respiration
 - i. A l'air d'avoir de la peine à respirer ?
 - ii. Fait du bruit quand respire ?
 1. Ressemble à quoi ?
 - c. Hémodynamique
 - i. Chaud ? froid ?
 - ii. Rouge ? blanc ? bleu ?
2. Caractériser la fièvre
 - a. À combien ? (!!! > 38)
 - i. Prise où ?
 - b. Début ?
 - c. Évolution ?
 - d. Facteurs modifiants
 - i. Médicament
 - e. Récurrence
3. Symptômes associés
 - a. Sueurs
 - b. Convulsion
 - c. Raideur de nuque
 - d. Se tient l'oreille
 - e. Toux
 - f. Vomissement
 - g. Diarrhée / constipation
 - h. Couleur urinaire, quantité
 - i. Boutons, éruption cutanée
4. Pleurs ? a l'air inconfortable ?
5. Alimentation ? boisson ?
6. Croissance
 - a. Courbe PC
 - b. Taille
 - c. Poids
7. Vaccination
8. ATCD personnels

9. Déroulement de la grossesse ? complication
10. Naissance (voie basse ? césarienne ? complication ? à terme ?)
11. Adaptation néonatale ? (1^{ère} minute, 1^{ère} semaine)
12. Anamnèse maternelle
 - a. Tabac
 - b. Alcool
 - c. Médicaments
13. Anamnèse psychosociale
 - a. Conjoint
 - b. Foyer
 - c. Travail
 - d. Stress
 - e. Surmenage
14. ATCD familiaux
 - a. Développement
 - b. Maladie

Examen clinique

☑ complet et minutieux (conscience, respiratoire, cardiaque/circulatoire, abdomen, uro-génital, ORL, peau, oculaire, ostéoarticulaire)